

Fecha Última Actualización: 05-04-2022 21:25:51

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Alfredo Hernan Espinoza Gonzalez
Edad : 71a 2m 21d
Dirección : Pje Las Dedaleras 3573 V.Los Prados Iii

Rut : 6.345.580-6
Fecha Nacto: 15/01/1951
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2203993
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7123 5979

N° Epicrisis
300250

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 03/03/2022 17:23

Días Estadía: 33

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 05/04/2022 21:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Convulsión

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

Médicos: Poliomieltis desde infancia con compromiso braquiocrural derecho; HTA; Sd. de caídas de larga data.

Quirúrgicos: (-)

Fármacos: Losartán (familia no recuerda dosis)

Alergias: (-)

Hábitos: Tabaco (+) al menos 5 cigarrillos/día. Alcohol (-), Drogas (-).

Sociales: Vive solo, jubilado. Trabajó como auxiliar de aseo en hospital. Familia no tiene claro nivel de escolaridad. Requiere bastón para caminar.

Inmunizaciones (influenza, neumococo, covid): Desconocido

Motivo de Consulta: Status convulsivo

Paciente con antecedentes descritos, el 03/03 a las 11 am sufre caída a nivel y contusión fronto-orbitaria derecha. Tras esto fue llevado a SAPU en donde presentó convulsión TCG de menos de 5 min. Al parecer con recuperación ad integrum. En este contexto fue llevado a SU HSR, en donde presentó otra convulsión TCG, esta vez yugulada con diazepam. Se tomó TC cerebro en donde destaca edema vasogénico en región prefrontal izquierda, con hiperdensidad pequeña asociada, no compatible con historia de TEC. Al examen físico destaca en sopor superficial, cánula mayo en vía oral. Obedece ordenes simples; PC impresiona CV conservados por amenaza, OCM conservada, RFM isocoria, sin PFC evidente. Motor: moviliza HC izquierdo al menos M3. En HC derecho con paresia M3 en ESD y M2 en EII (atrofia marcada en esta EE); Sensibilidad impresiona conservada. Se interconsulta a neurocirugía, impresiona lesión de origen secundario, sin efecto de masa, por lo que se sugiere RM de encéfalo con contraste y TAC TAP para búsqueda de neoplasia primaria. Se carga con fenitoína, no impresiona en status por lo que se desestima EEG inicialmente.

Evoluciona en malas condiciones generales, sopor profundo, posturas de descerebración ocasional, mal manejo de secreciones. Se decide manejo avanzado de vía aérea con IOT y conexión a VMI. En ese contexto ingresa a UPC para manejo.

Laboratorio ingreso

03/03/22: pH 7.15, pCO2 51 HCO3 17; Hb 14,4, Gb 19,555, Plt 435,000; Crea 1,02 BUN 9; PCR 13; ELP 140/3,55

Imágenes ingreso

Fecha Epicrisis : 05/04/2022 21:25

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 05-04-2022 21:25:51

Página 2 de 3

03/03/22 TAC de cerebro sin contraste: Sin sangrado. Hipodensidad lóbulo fronto-parietal izquierdo. No impresiona desviación de línea media.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- Lesión intraaxial en estudio
 - Sospecha metástasis de primario desconocido
 - Status epileptico secundario
- TEC leve
- PCR COVID negativa
- Atcd: HTA, poliomielitis en infancia (secuela motora: BC derecho). Autovalente. Tabaquismo.

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN

1.- HEMODINÁMICO: VEC conservado desde su ingreso, HDN con requerimiento de DVA con noradrenalina de forma fluctuante durante su evolución, principalmente en relación a intercurencia infecciosa con NAVM. Sin compromiso perfusional. Posteriormente se logra suspensión de DVA. Evoluciona en malas condiciones y se maneja en fin de vida.

2.- VENTILATORIO: El 03/03 se decide IOT y conexión a VMI protectora en contexto de status epiléptico. Sin mayor conflicto de intercambio gaseoso durante su evolución. Se suspende precozmente sedación para iniciar proceso de weaning, sin embargo, se torna dificultoso debido a alteración de fuelle torácico con incapacidad de sostener ventilación de forma independiente. Se realiza progreso de VMI V/C a CPAP con requerimiento de soporte de forma prolongada, radiografía de tórax de control muestra aumento en la progresión de masa tumoral en ápice de hemitórax derecho, por lo que se decide instalación de TQT el 16/03. Finalmente, el 19/03 se logra disminución progresiva de soporte hasta suspensión de ventilación asistida y destete de O2 el 25/03. Evoluciona con intercurencia de foco respiratorio, aumento de secreciones y requerimientos de oxígeno hasta 4L de O2 por TQT.

Hoy con mayor compromiso respiratorio, se mantiene BIC de morfina para manejo sintomático.

3.- INFECCIOSO: En contexto de parámetros inflamatorios al alza, el 05/05 se inicia tratamiento empírico con Ampicilina - Sulbactam, suponiendo foco pulmonar. Sin nuevos episodios de peak febriles. Sin deterioro clínico. 11/03 destacan parámetros inflamatorios al alza, por lo que se decide panculti var HC CVC + periféricos + CAET + URC. Debido a quiebre clínico se escala a meropenem + vancomicina. CAET (+) Klebsiella pneumoniae BLEE. Se suspende vancomicina, se mantiene meropenem (9) (S intermedia) y se agrega amikacina en NBZ (7° día).

NAVM por KPN BLEE tratada (último día de tto 24/03). Subfebril aumento de secreciones bronquiales y elevación de parámetros inflamatorios por lo que se pancultivo e inició terapia ATB empírica con Imipenem (30/03). Inicialmente evoluciona de forma tórpida, afebril pero con requerimientos de O2. Por mal pronóstico global del paciente se completan 6 días de antibiótico y se suspende en manejo proporcional.

4.- NEUROLÓGICO: Status epiléptico secundario a MTT cerebral. 07/03 se reinicia fenitoína en dosis 50mg AM - 100mg PM. Levetiracetam se mantiene en dosis habitual. Posteriormente se suspende fenitoína con buena respuesta por parte del paciente sin evidenciar nuevas crisis epilépticas.

5.- ONCOLÓGICO: Debut de cáncer pulmonar con MTT cerebral, Etapa IV asociado a síndrome de vena cava superior, Corticoterapia con dexametasona 4mg c/8hrs. Se realiza biopsia transbronquial el 10/03, compatible con carcinoma espinocelular. Plantear pasos a seguir para diagnóstico y sobre todo, tratamiento proporcional, acorde a etapa avanzada y comorbilidades asociadas.

Paciente presentado en comité oncológico, se decide RT paliativa torácica y cerebral para Sd VCS y MTT cerebrales. Por dificultad de realizar RT cerebral se decide solo RT torácica, 1 sesión.

6.- RENAL/MEDIO INTERNO: Función renal se mantiene estable durante su evolución. En 2 ocasiones presentó hipernatremia 149 mEq/L, sumado a BH (-), por lo que se repone agua libre por SNG (actualmente suspendida) Paralelamente presentó alcalosis respiratoria con D(A-a)O2 34, por lo que se presume en relación a VM. Tras suspensión, con mejoría paulatina de GSA.

Posteriormente evoluciona con hipernatremia que no respondió a volemicización, hoy mantiene hipernatremia y hiperkalemia, se conversa con familia y equipo y se decide manejo proporcional por condición basal del paciente.

Fecha Epicrisis : 05/04/2022 21:25

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:46

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 05-04-2022 21:25:51

Página 3 de 3

7.- ETE: En contexto de hallazgo al ingreso de trombosis VCS y obstrucción parcial de arteria pulmonar derecha, se decide anticoagulación con HBPM 80 mg c/12hrs. Hoy se decide suspender anticoagulación debido a manejo de fin de vida.

8. Manejo fin de vida: Para manejo de disnea se mantuvo BIC de morfina con buena respuesta aliviando síntomas. Hoy martes 5/04 a las 16.35 paciente fallece debido a condición base.

Lab reciente

05/04: ELP 167/6.94/128

04/04: Crea 1.1, BUN 109, ELP 164/5.24/129, GSV pH 7.278, PCO2 65.9, HCO3 30.1, GOT 58, FA 268, BiIT 0.29, BiID 0.23, PCR 146.1, Hb 11.1, Gb 22000, PQT 334K

Microbiología

11/03 CAET: Klebsiella pneumoniae BLEE > 1,000,000 UFC; (S) Amikacina (I) Meropenem.

11/03 HC CVC, periféricos (-)

11/03 Urocultivo (-)

Anatomía patológica

17/03 Preinforme Bp: Se reconoce escaso material hemático, células cilíndricas ciliadas normotípicas, y algunas células de citoplasma eosinófilo y núcleos grandes hipercromáticos de contornos irregulares, las que se disponen aisladas o en pequeñas láminas, características que podrían corresponder a Carcinoma espinocelular.

Diagnóstico de Egreso

OTROS TRASTORNOS DEL PULMÓN - CANCER DE PULMON METASTASICO

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente crítico, hoy en peores condiciones, con mayor requerimientos de O2 y empeoramiento mecánica ventilatoria. Presento hipernatremia, hiperkalemia e hipercalemia.

En la mañana normotenso, taquicardico, afebril, ventilado por TQT con mecánica regular con 4 L O2 en sopor profundo, no conecta con el medio.

Hoy a las 16:35 fallece debido a condición base y estado crítico.

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

José Joaquín Iturrieta Daure

STAFF

Jorge Andrés López Ruiz-Eskide

Becado/Residente

Juan Opazo Cereceda

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 05/04/2022 21:25

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:46

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar